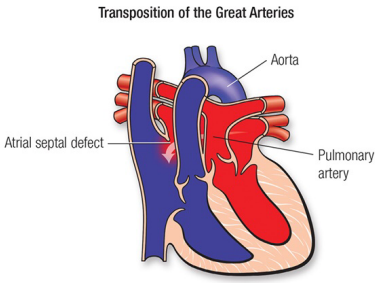
<2020 본 3 학년말고사 – 소아청소년과>

소아과 45 문제중 42 문제 복기. 전반적으로 탈야마.

1. 생후 2 일 남아가 경련으로 병원에 왔다. 임신 나이 39 주, 출생체중 3.3kg 으로 질분만으로 태어났다. 아래턱이 작았고, 입천장 갈림증이 있었다. 복장뼈 왼쪽 아래 가장자리에서 3/6 도의 범수축기 심잡음 들렸다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 본 환아의 면역 상태를 보기위해 꼭 해야하는 검사는?
   혈색소 13.5g/dL, 백혈구 9600/mm3, 혈소판 450000/mm3, 포도당 95mg/dL, Na/K 135/3.9, 칼슘 5.5(참고치, 7~12), 인 9.5(참고치 4.8~8.2) CRP 0.8
   - 혈청 보체
   - 절대중성구수
   - 혈정면역글로불린 G
   - 백혈구살균기능검사
   - T 림프구세군(subset)

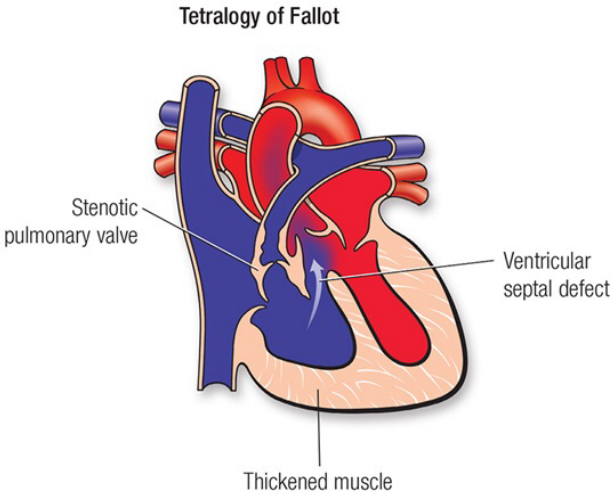
2. 다음 중 소아 발달 곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   - 일반형에는 소화기, 호흡기, 키, 체중등이 포함된다
   - 일반형은 s 형으로 영아기, 사춘기에 급성장한다
   - 신경형은 2 세에 벌써 성인의 80%정도로 완성한다
   - 림프형은 10~12 세에 어른의 2 배에 달한다.

3. 다음 선천성 심기형에 대한 치료 방법으로 적절하지 않은 것은?



   - 풍선 중격 절제술
   - 칼날 중격 절제술
   - PGE-1
   - 대혈관 전위술
   - Lecompte 술

4. 선천성 심질환을 가진 ?세 남아가 켁켁거리며 호흡 곤란 호소하다가 의식 소실하였다. 적절한 치료는? (답확실하지 않음)



   - IV 에피네프린
   - 수액공급
   - 피하 모르핀
   - IV 로라제팜

5. 24 개월 남아가 하루전부터 심하게 보채고 피 섞인 설사를 해 병원에 왔다. 친구들과 며칠전 햄버거를 먹은 뒤

설사와 복통이 있었는데 심하지 않아 치료받지 않았다고 한다. 체온은 39 도, 맥박수는 12 이다. 혈압은 90/40 이다. 어제 낮 이후로 소량의 소변을 2 회 배출했다. 혈액 도말 검사에서 schistocyte 가 관찰되었다. 가장 적절한 진단은?

백혈구 17500, 혈색소 9.2, Na 125, K 3.0, BUN/Cr 36/2.3, total bilirubin 7.8, direct bilirubin 0.9

- 로타바이러스 장염
- 콜레라 감염
- 황색 포도알균 장염
- 요독성용혈 증후군
- 클로스트리듐디피실 장염

6. 다음중 postmenstrual age 를 뜻하는 것은?
   - Corrected age
   - Gestational age
   - Chronological age
   - Gestational age + chronological age
   - Gestational age + corrected age

7. 6 살 여아가 하루전부터 시작된 하지 점출혈로 내원했다. 몇일 전에 감기로 고생했었다. 양쪽 발목과 무릎 관절에 통증이 있었다고 한다. 현재는 통증이 없다. 해줄 수 있는 치료는?

   백혈구 5500, 혈색소 13.5, 혈소판 250000, BUN/Cr 24/0.6, ASO 100(참고치 120~160), C3 85(참고치 77~195)
   - 이부프로펜
   - 스테로이드
   - IVIG
   - 혈소판 수혈
   - 경과관찰

8. 3 세 남아가 1 일 전부터 시작된 간헐적 복통으로 왔다. 발열이나 복막자극 징후는 없었으며 내원하기 1 시간 전에 젤리와 같은 붉은 혈변을 봤다고 한다. 다음은 복부 초음파 사진이다. 치료는?



   - 개복 정복술
   - 공기 정복술
   - 수액 공급

9. 정상 신생아의 혈액순환으로 옳은 것은?
   - 출생 후 폐동맥 저항이 급격하게 증가한다
   - 출생 후 전신 혈관 저항이 급격하게 증가한다
   - 동맥관은 생후 2-3 년에 자연스럽게 닫힌다
   - 우심실 박출량이 좌심실 박출량의 1.3 배이다
   - 우심방으로 들어온 정맥혈은 대부분 동맥관으로 흐른다.

10. 10 개월 아이가 지속적인 마른기침과 천명으로 내원했다. 이 아이가 천식으로 진행될 가장 큰 요인이 있다면

무엇일까?

- 부모님의 아토피 피부염
- 환자의 아토피 피부염
- 환자의 알레르기 비염
- 7% 호산구

11. 2 세 아이가 1 일 전부터 쌀뜨물 같은 수양성 설사를 하고 구토도 하였다. 변에 백혈구나 잠혈은 없었다. 치료를 하니 금방 호전되었다. 가장 가능성 있는 원인은?
    - 이질
    - 살모넬라
    - 로타바이러스
    - 대장균

12. 수동면역 적응증이 아닌 것은?
    - 일본뇌염
    - RSV
    - HBV
    - HAV
    - 광견병

13. 신생아 가사의 hypoxic ischemic encephalopathy 에서 excitotoxic injury 를 유발하는 물질은?
    - Glutamate

14. 생후 7 일 된 여아 먹지 않고 자려고만 해서 내원하였다. 진한 노란색 소변을 보다가 1 일 전 부터는 소변이 거의 나오지 않았다고 한다. 체온은 정상이었으나 혈압이 낮고 맥박은 약하고 빨랐다. 시진 상 앞숫구멍 함몰 소견이 있었고 피부와 잇몸에 검게 색소침착이 있었다. 음핵이 커져 있었으며 모호한 성기가 관찰되었다. 해야 하는 검사는?

WBC 정상 Hb 정상 PLT 450,000 Na 123, K 7.8

    - 수분제한검사
    - 17-OH progesterone
    - TSH

15. 8 세 남아가 39 도 이상의 고열과 인후염을 주소로 내원하였다. 인후는 심하게 충혈되어 있었고 연구개와 목젖에 출혈 반점이 있었다. 편도는 점액 농성 삼출액으로 덮여있었다. 혀 사진은 다음과 같았다. 치료는? (퍼시픽 KMLE 사진으로 나옴)



    - 아목사실린
    - 클라리스로마이신
    - 클린다마이신
    - 이부프로펜
    - 덱사메타손

16. 평균 기도 압력을 높이는 방법으로 ③에 해당하는 방법은?

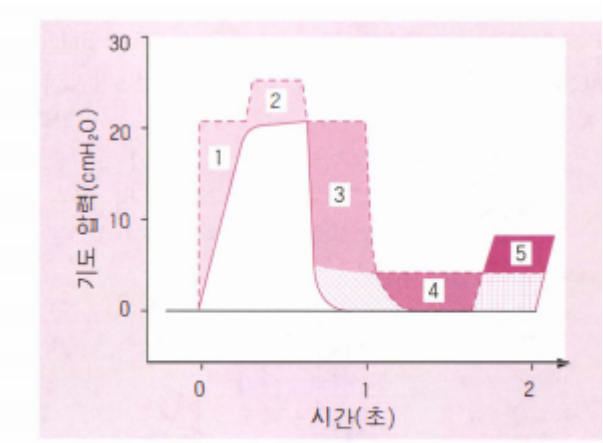


그림 11 – 30 인공 환기 요법에서 산소화 개선을 위한 평균 기도압(MAP)을 높이기 위한 다섯 가지 방법

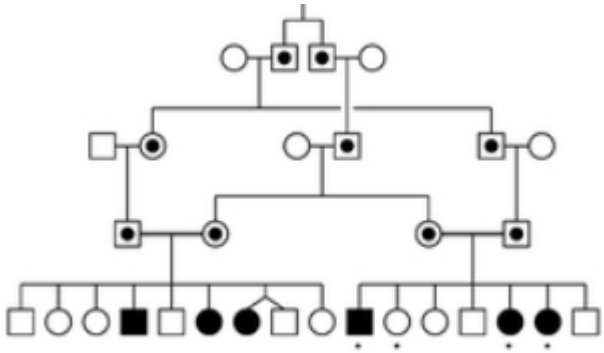
- 흡기의 flow rate 증가
- 최대 흡기 압력의 증가
- 흡기와 호기 시간 비 조정 (호기 시간의 감소)
- 호기 말 양압 증가
- 호흡 횟수의 증가

17. 생후 8 일된 남자 아이가 신생아 선별 검사에서 갑상선 자극호르몬 수치가 높아서 시행한 갑상선 기능 검사 결과가 다음과 같았다. 원인으로 가장 흔한 것은?

트라이아이오도티로닌 : 100 ng/dL (75-260), 유리 티록신 : 0.3 ng/dL (0.9-2.6) 갑상선 자극호르몬 : 58 μU/mL (0.5-6.5)

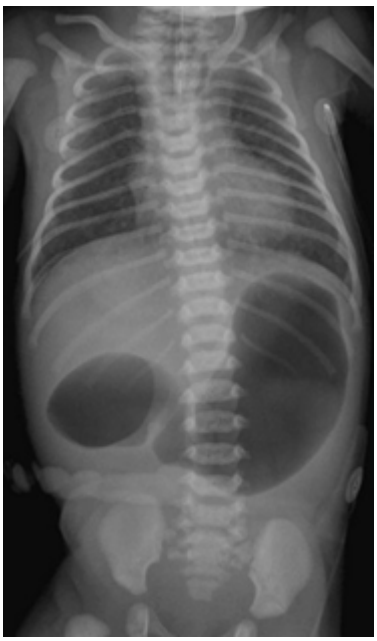
- 딴 곳 갑상샘
- 갑상샘 무형성
- 효소 결핍
- 만성 림프구성 갑상선염

18. 다음과 같이 유전되는 질환으로 옳은 것은? (아래 그림과 비슷한 AR 가계도 주어짐)



- 갈락토스혈증
- Duchenne muscular dystrophy
- 말판 증후군
- 저인산염혈증 구루병

19. double bubble sign 보이는 CXR 사진, 30%에서 동반하는 증후군은?

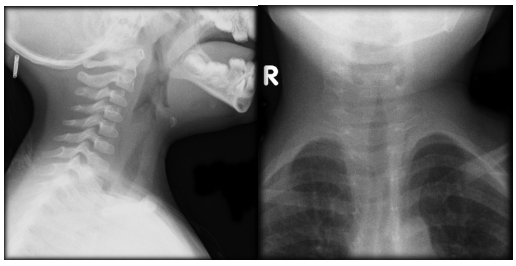


- 누난 증후군
- 다운 증후군

20. 영유아에서 호흡곤란이 잘 일어나는 이유로 맞는 것은?
    - 기관지 평활근이 적고 미숙하다.
    - 후두 연골이 발달하여...
    - 기관지 내경이 넓고 후두개가 짧아서 구강호흡을 한다.
    - 분비물이 적게 분비된다.

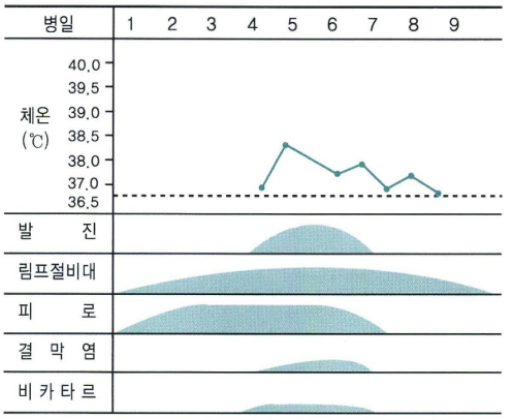
21. 5 세 남아가 점점 걷기가 서툴러져서 병원에 왔다. 임신 나이 40 주, 출생 체중 3200g 질식분만으로 태어났다. 15 개월에 혼자 걷기 시작하였으나 4 개월 전부터 점차 다리를 넓게 벌리고 허리를 흔들어 걷고, 자주 넘어졌다. 이른 아침과 오후에 증상 차이는 없었다. 혼자 일어서기를 힘들어하며, 배를 내밀고 서 있었다. 장딴지 근육이 딱딱하고 비대해져 있었다. 진단은?
    - 근 디스트로피
    - 중증근무력증
    - 뇌성마비

22. 2 세 여아 발열과 킁킁거림을 주소로 내원. 산소포화도 95% 호흡수 분당 40 회. 흉부함몰 있었고 예방접종은 다 맞음. 다음은 가슴과 목 옆면 x 선 사진이다. 치료는?



(subglottic narrowing)
    - 에피네프린 흡인
    - 기관삽관

23. 다음의 질환에 해당하는 설명은?



    - 사람이 유일한 숙주이다.
    - 치료는 아목시실린이다.
    - 기침, 결막충혈, 콧물이 특징적이다.
    - 진단을 위해서는 코플릭 반점 확인이 필요하다.
    - 귀밑 침샘염이 70%에서 나타난다.

24. 5 세 남아가 팔다리 접힘 부위 가려움으로 내원. 딱지 있었고 1 년 이상 지속되어 태선화 관찰됨. 눈 주위 색소침착보였고 환자 본인과 부모님 모두에게 알레르기비염 있었음. 진단은?
    - 아토피피부염
    - 접촉피부염

25. 3 세 여아가 배에서 덩이가 만져져 내원하였다. 혈뇨가 있었으며 덩이는 중앙선을 넘지 않았다. 진단은?
    - 신경모세포종
    - 윌름종양
    - 급성림프구성 백혈병
    - 림프종
    - 골종양

26. 5 세 여아가 발열과 두통, 구토로 병원에 내원하였다. 2 주 전 손과 발에 발진이 나고 입안에도 뭐가 나서 밥을 잘 못먹은 적이 있었다. 검사결과는 다음과 같다.

원인은?

- 뇌척수액 : 압력 90mmH2O, 백혈구 15/mm3(중성구 2%, 림프구 96%), 단백질 45mg/dL, 포도당 70mg/dL
    - 수막염균(Neisseria meningitidis)
    - 녹농균(Pseudomonas aeruginosa)
    - B 군 사슬알균(group B streptococcus)
    - b 형 인플루엔자균(Haemophilus influenzae type B)
    - 엔테로 바이러스(enterovirus)

27. 6 세 남아가 키가 작아서 병원에 왔다. 키 102cm(3 백분위수 미만), 체중 12kg(3 백분위수 미만)이었다. 최근 1 년 동안 키가 3cm 컸다. 아버지는 175cm, 어머니는 160cm 였다. 골연령은 4 세였다. 해야 할 검사는? 검사 결과에서 IGF-1 이 낮았다.
    - 인슐린 투여 후 성장호르몬 농도
    - 경구 포도당 복용 후 성장호르몬 농도
    - 염색체 검사
    - 소변 검사

28. 24 개월 된 아이가 발달평가를 위해 내원하였다. 계단 혼자서 오르고 잘 뛰지만 세발자전거는 타지 못한다. 직선은 그리지만 동그라미는 못그린다. 간단한 단어 5~6 개 말하지만 두 단어를 붙여서 문장으로 말하지 못한다. 혼자 숟가락 들 수 있지만 옷은 혼자 못입는다. 발달 이상 있는 영역은?
    - 대근육
    - 소근육
    - 사회성
    - 언어

29. DKA 설명해주고 가장 우선적인 치료.

칼륨: 4.2, pH 7.1, 혈당 500 정도

- 0.9% normal saline
- 중탄산염 투여
- 지속형 인슐린투여
- 칼륨없는 수액에 인슐린 섞어 투여

30. 5 세 남아가 6 일 동안 지속되는 발열로 병원에 내원하였다. 항생제를 먹어도 열이 내리지 않았고 혀가 빨게지고 손발 부종과 반점 있었으며, 입술이 갈라지고 빨게졌다. 목에 림프절이 부어있다. 백혈구 16000 그외 혈액검사 수치 주어짐. 치료는?
    - IVIG(정맥면역글로불린)

31. (해당 유형으로 2 문제 출제) 만삭아. 40 주에 정상분만한 환아가 황달을 주소로 내원하였다. TSH 80 ml/U, Tyrosine0.3ng/dL.그외 17-OH-progesterone 등등 다른 수치 정상.
    - 최종산물 투여
    - 효소 대체 요법
    - 식이 요법
    - 조효소 투여

32. 위와 동일한 문제

33. 생후 12 시간 아기가 황달로 내원했다. Total bilirubin 13, Direct bilirubin 0.8, Hb 8 일 때 가장 가능성 있는 원인은?
    - Hemolytic anemia
    - 모유황달
    - 담관 정체증

34. 6 세 남아가 5 일전부터 몸이 붓고 소변적게 본다고 병원에 왔다. 구토 설사 없고 체중이 2 키로 증가. 혈압 체온 정상. 얼굴은 부어있고, 청진에서 호흡음과 심음은 정상이었다. 배는 불러있으나

덩이는 만져지지 않았다. 오목부종 있었다. 추가로 시행할 소변검사는?

- 세균배양
- 미세알부민정량
- 24 시간 단백질 정량
- 단회 칼슘/크레아틴 비
- 베타 2 저분자 글로불린 정량

35. 수두 설명해주고 acyclovir 투여 적응증인 아이 고르기
    - 이제까지 접종을 다한 13 세 이상 소아 환자에서 발생한 수두
    - 스테로이드 사용중인 소아
    - 가족중에 감염된 사람이 없을경우
    - 아세트아미노펜을 지속적으로 복용중인 소아

36. 신생아 진찰 정상 소견은?
    - 독성 홍반
    - 사경
    - cephalohematoma
    - 관절굴곡증

37. 아이가 지속되는 경련으로 내원했다. 몸 전체가떨리는 경련이었으며 하루에 수십회 반복되었다. MRI 에서 뇌 곳곳에 결절이 보였으며, 피부에는 음영이 감소된 반점이 보인다. 진단은?
    - 결절경화증
    - neurofibromatosis
    - 스터지 웨버 신드롬

38. 2 세 남아가 안면창백을 주소로 내원했다. 9 개월까지 모유수유 하였고, 그 이후부터는 생우유만 매일 2L 씩 섭취중이다. 혈액검사 결과가 아래와 같을때 이 환아에게서 높게 측정될 수 있는 수치는?

    Hb 8.5, Hematocrit 26.2%, MCV 71

    - 혈청 철
    - 혈청 페리틴
    - 그물 적혈구
    - 트랜스페린 포화도
    - 총철 결합능

39. 출생 후 반응 없는 아기, 발바닥 자극 줘도 자발호흡 없음. HR 90 미만인 아기. 다음 치료는?
    - 양압 환기
    - 심장 마사지
    - 기관삽관
    - 에피네프린 정주

40. infectious mononucleosis 문제?

41. 우리나라에서 시행하고 있는 선천성 대사이상 선별 검사 중, 선천성 부신 항진증을 위한 항목은?
    - TSH
    - T4
    - 17-OHP
    - Galatcose

42. 발열, 기침, 콧물로 내원한 환아. 결막 충혈있고 입안에 하얀반점이 있고 부어있다. 피부 발진이 있었다. 다음 질환으로 인한 합병증 중 사망률이 높은것은?
    - 폐렴
    - 뇌염
    - 신장 질환
    - 관절염